

13 - 13- Anxiolytiques - Pr. ZAOUI

(0:00 - 0:14)

Chers étudiants, nous allons voir aujourd'hui un cours sur les anxiolytiques. Les anxiolytiques sont des médicaments capables de réduire ou de supprimer l'anxiété. C'est pourquoi ils sont prescrits dans l'anxiété.

(0:15 - 0:37)

Il y a une famille qui est le plus souvent prescrite, c'est la famille des benzodiazépines, qui ont des propriétés pharmacologiques communes. On va voir qu'à côté de leurs effets anxiolytiques, on peut avoir d'autres effets qui peuvent être utilisés en thérapeutique. Les anxiolytiques sont caractérisés par une bonne efficacité et une bonne tolérance parce qu'ils ont une marge thérapeutique qui est large.

(0:37 - 1:00)

Cependant, ils exposent un risque d'accoutumance et de dépendance quand on ne respecte pas les doses et on prescrit le médicament sur une durée prolongée, d'où la nécessité d'une durée de prescription qui sera limitée. Dans ce cours, nous allons voir la classification des anxiolytiques. Nous allons faire un rappel pour comprendre le mécanisme d'action.

(1:01 - 1:44)

Nous allons parler des propriétés pharmacologiques, leurs pharmacodynamiques, leurs indications, contre-indications, leurs effets indésirables, leurs interactions médicamenteuses, leurs précautions d'emploi et on va parler un petit peu de la surveillance du traitement. Au terme de ce cours, vous devez être capable de donner la classification des anxiolytiques, d'écrire leurs mécanismes d'action, citer leurs propriétés pharmacologiques, citer leurs indications, leurs contre-indications, leurs effets indésirables, citer les interactions médicamenteuses, leurs précautions d'emploi et citer les éléments de la surveillance. La classification des anxiolytiques se fait en fonction de leur structure chimique.

(1:45 - 2:10)

On distingue les tranquillisants benzodiazépiniques et les tranquillisants non benzodiazépiniques. Les tranquillisants benzodiazépiniques ont les mêmes propriétés pharmacologiques qu'on va voir tout de suite. La différence entre ces molécules, ça concerne surtout les propriétés pharmacocinétiques, des demi-vies qui peuvent être différentes d'une molécule à l'autre, un délai d'action qui peut être différent aussi.

(2:10 - 2:33)

La première molécule qui a été découverte dans cette classe, c'est la chlordiazepoxyde qui a été découverte par hasard par un pharmacologue qui travaillait pour une industrie et qui cherchait un colorant. Cette molécule n'a pas montré de propriétés pharmacologiques en tant que colorant. Après quelques années, on a mis en évidence ses effets sédatifs et ses effets anxiolytiques.

(2:35 - 3:02)

On passe aux autres tranquillisants non benzodiazépiniques. Il y a les antihistaminiques comme l'hydroxyzine qui est indiqué dans les anxiétés mineures. On a d'autres médicaments comme le typhoxyne et le captodiamine qui sont surtout prescrits lorsqu'on a une anxiété accompagnée de signes physiques, donc les anxiétés avec manifestation psychosomatique.

(3:03 - 3:24)

Et on a la buspirone. Cette molécule ne donne pas de dépendance, ne donne pas d'effet sédatif et nécessite un délai d'action qui peut arriver jusqu'à 15 jours. Les anxiolytiques benzodiazépiniques agissent surtout par le biais de la neurotransmission GABAergique.

(3:24 - 3:59)

Le GABA est un neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central qui a une influence apaisante sur le cerveau et sur le corps humain. Le GABA agit en se fixant sur son récepteur et cette fixation du GABA sur son récepteur va donner une ouverture du canal chlore avec une entrée du chlore, ce qui va diminuer l'excitabilité de la cellule nerveuse. Un autre schéma expliquant l'action du GABA.

(4:01 - 4:35)

L'impulsion nerveuse provenant du neurone présynaptique aboutit à la libération du GABA dans l'espace synaptique. Celui-là va se fixer au niveau de son récepteur, va donner l'ouverture du canal chlore ce qui va donner l'entrée du chlore et ceci va donner une inhibition de l'impulsion nerveuse qui est venue du neurone présynaptique. Quel est l'effet des benzodiazépines? Les benzodiazépines augmentent l'action naturelle du GABA.

(4:36 - 5:03)

Ces benzodiazépines aident le GABA à faire son effet. Ils entraînent une augmentation de l'affinité du GABA pour son récepteur ce qui va aboutir à une ouverture du canal chlore et une inhibition ou un blocage de l'impulsion nerveuse. Plusieurs propriétés pharmacologiques ont été décrites avec les anxiolytiques.

(5:04 - 5:30)

Ils ont un effet anxiolytique qui est rapide et puissant surtout pour les benzodiazépines et qui

améliore l'état psychique et somatique du patient. Ils ont un effet hypnotique qui explique la somnolence qui survient lors de l'instauration du traitement. C'est un effet qui est dose dépendant donc qui peut s'atténuer si on diminue les doses et qui disparaît en quelques jours malgré la poursuite du traitement.

(5:31 - 6:03)

Ils ont aussi un effet myorelaxant donc il diminue le tonus musculaire ce qui explique que certaines benzodiazépines sont utilisées dans le tétanos pour arrêter l'espace musculaire. Les anxiolytiques ont un effet anticonvulsivant qui leur permet d'arrêter les convulsions dans certains cas. Ils ont un effet amnésien surtout qui porte sur la mémoire entérograde c'est à dire le patient oublie les faits qui se passent après la prise du médicament.

(6:03 - 6:19)

Ceci peut être mis à profit en thérapeutique quand on veut lors des situations qui sont inconfortables par exemple lors d'examens endoscopiques. On va répondre à cette QCM. Les anxiolytiques ont un effet antidépresseur.

(6:21 - 6:37)

FAUX Un effet amnésien. VRAI Un effet contracturant musculaire. FAUX Ils donnent un relâchement musculaire.

(6:38 - 6:54)

Un effet anticonvulsivant. VRAI Un effet hypnotique. VRAI On passe à la pharmacocinétique des anxiolytiques.

(6:55 - 7:11)

Leur absorption est bonne par voie orale donc on peut les trouver sous forme de comprimés. Généralement leur biodisponibilité peut atteindre 90%. Mais leur absorption a une rapidité variable en fonction des molécules.

(7:11 - 7:30)

Par exemple elle est moins de 2h pour le diazepam et l'alprazolam et plus de 2h pour l'oxazepam. Donc le médecin va choisir entre les médicaments en fonction de l'état du patient. S'il veut une action rapide il va choisir des médicaments qui sont rapidement absorbés au niveau digestif.

(7:30 - 7:52)

Et si l'action rapide n'est pas recherchée on peut choisir les molécules qui s'absorbent lentement

par voie digestive. Leur liaison protéique est importante mais elle ne donne pas d'interaction médicamenteuse importante. Leur métabolisme se fait au niveau du foie avec possibilité de production de métabolites actifs qui peuvent prolonger l'action du médicament.

(7:53 - 8:09)

Leur demi-vie peut être courte ou longue en fonction des médicaments. Elle est prolongée chez le sujet âgé, chez l'insuffisant hépatique et l'insuffisant rénal. Parce qu'ils ont un métabolisme hépatique et une élimination rénale.

(8:10 - 8:36)

Et chez le sujet âgé généralement on note une diminution de l'élimination rénale qui peut expliquer l'accumulation du produit chez le sujet âgé. Leur élimination est urinaire que ce soit du principe actif ou du métabolite. Et on note un passage dans le lait maternel qui fait que ces médicaments sont généralement déconseillés lors de l'allaitement maternel.

(8:36 - 8:59)

Parce qu'ils peuvent donner une sédation chez le nouveau-né, des problèmes de fusion et des problèmes de prise de poids. Ces médicaments peuvent être indiqués dans l'anxiété que ce soit les manifestations psychiques ou les manifestations physiques liées à l'anxiété. Les insomnies d'endormissement puisqu'ils ont un effet sédatif.

(9:00 - 9:29)

Ils peuvent être indiqués pour les manifestations neurologiques d'un syndrome de sevrage après arrêt d'alcool chez les alcooliques chroniques. Et les crises convulsives surtout chez l'enfant et le nourrisson puisqu'ils ont un effet anti-convulsif. Avec les anxiolytiques on peut avoir une somnolence qui est l'effet indésirable le plus fréquent et qui peut disparaître en quelques jours.

(9:29 - 9:53)

Cela se voit surtout au début du traitement ou après une diminution de la posologie puisque c'est un effet dose dépendant. On a vu que ces anxiolytiques donnent une amnésie entérograde qui peut être considérée comme un effet indésirable. Parce que cette amnésie entérograde est utilisée lors des soumissions médicamenteuses.

(9:53 - 10:12)

Quand un agresseur veut que sa victime ne se rappelle plus des faits. Et il lui donne un sebazodiazepine pour cet effet d'amnésie entérograde. Ces médicaments exposent à une dépendance que ce soit physique ou psychique.

(10:13 - 10:35)

S'il n'y a pas un arrêt progressif de ces médicaments, on peut avoir un syndrome de sevrage qui peut se manifester par une anxiété, une insomnie, des vomissements et des tremblements. Cette dépendance se voit surtout quand on utilise des anxiolytiques à forte dose et d'une façon prolongée. D'où la nécessité d'arrêter le traitement progressivement.

(10:35 - 11:14)

On peut avoir un phénomène de revent, c'est-à-dire à l'arrêt du médicament on voit des manifestations initiales pour lesquelles le patient a consulté qui apparaissent après l'arrêt du médicament. On peut noter des réactions paradoxales, c'est-à-dire au lieu de voir un effet tranquilisant, on peut avoir une agitation, une agressivité et des troubles de l'humeur. Les benzodiazépines peuvent donner des effets déprimeurs respiratoires surtout s'ils sont utilisés par voie intraveineuse ou s'ils sont utilisés chez le sujet âgé ou chez le sujet ayant une insuffisance respiratoire.

(11:15 - 11:52)

On peut noter des éruptions cutanées et des effets cardiovasculaires comme une hypotension. Les anxiolytiques sont contre-indiqués en cas d'allergie, en cas d'insuffisance hépatique sévère pour les molécules qui sont essentiellement éliminées par le foie, en cas d'insuffisance rénale sévère pour les molécules éliminées essentiellement par le rein et en cas d'insuffisance respiratoire aiguë pour les benzodiazépines parce qu'il y a un risque de dépression respiratoire. On va citer quelques interactions médicamenteuses de type association des conseillers.

(11:53 - 12:12)

On déconseille l'association des anxiolytiques avec l'alcool qui a un effet déprimeur du système nerveux central. Cet effet peut être majoré quand on administre avec lui les anxiolytiques, c'est-à-dire qu'on peut majorer la somnolence due aux anxiolytiques. Donc c'est une association des conseillers.

(12:12 - 12:47)

L'association de la buspirone avec certains médicaments comme l'erythromycine et l'hydraconazole est déconseillée parce que ce sont des inhibiteurs enzymatiques qui peuvent augmenter les effets de la buspirone. Il faut limiter la prescription des anxiolytiques au strict minimum nécessaire parce qu'il y a ce risque de dépendance si on prend le médicament en cours. De ce fait, on doit toujours vérifier si le traitement est nécessaire pour le patient.

(12:48 - 13:16)

Sinon, dès amélioration, il faut essayer d'arrêter le traitement et cet arrêt se fait progressivement. Généralement, la durée ne doit pas excéder 8 à 12 semaines, y compris la période de la

réduction de la posologie. Les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines doivent être informés et sensibilisés aux risques possibles de somnolence parce que cette somnolence peut être responsable d'accidents, que ce soit de la voie publique ou des accidents de travail ou des accidents domestiques.

(13:19 - 13:42)

La surveillance des effets reposera sur l'interrogatoire. Elle va concerner l'efficacité thérapeutique du traitement et ses effets indésirables. On cherche chez le patient s'il y a une amélioration de la symptomatologie avec disparition de l'anxiété et on vérifie l'observance, c'est-à-dire est-ce que le patient prend correctement son traitement parce qu'une mauvaise observance peut expliquer une inefficacité du traitement.

(13:42 - 14:05)

On va voir aussi est-ce qu'il y a une justification pour la poursuite ou non du traitement puisqu'on a dit que la durée du traitement doit être limitée. On va chercher les effets indésirables, par exemple une somnolence, une amnésie et les autres effets indésirables qui peuvent nécessiter une adaptation de la posologie. Une simple diminution de la posologie peut régler le problème de l'effet indésirable.

(14:07 - 14:31)

Si on note une inefficacité après une durée de traitement convenable, on augmente la posologie. Et quand cette augmentation de la posologie ne donne pas une efficacité, on peut changer une molécule par une autre molécule plus puissante et plus convenable au patient. En aucun cas on associe deux médicaments anxiolytiques parce que cette association n'est pas justifiée.

(14:33 - 14:54)

On va répondre à cette QCM. Les anxiolytiques peuvent être arrêtés brutalement. Faux.

On a dit qu'ils doivent être arrêtés progressivement. Peuvent donner une agitation. Vrai.

Dans les réactions paradoxales. Peuvent donner une dépression respiratoire. Vrai.

(14:55 - 15:03)

Peuvent donner une dépendance. Vrai. Peuvent être contre-indiqués en cas d'insuffisance hépatique sévère.

(15:03 - 15:04)

Vrai.